

Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH)

1. Introducción y relevancia clínica

El Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un **patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad**, que interfiere significativamente en el funcionamiento académico, social y familiar del niño.

Es una de las condiciones neuropsiquiátricas más frecuentes en la infancia:

- **Prevalencia:** 5–8% en edad escolar (OMS, DSM-5).
- **Inicio:** antes de los 12 años.
- **Predominio masculino:** 2:1 en la infancia, igualándose en la adultez.
- **Alta comorbilidad:** ansiedad, trastornos de conducta, aprendizaje y ánimo.

El TDAH **no es un problema de disciplina o de crianza**, sino una alteración del control atencional y de la inhibición conductual, con base neurobiológica bien establecida.

□ En el **EUNACOM**, es una pregunta frecuente tanto en el área pediátrica como psiquiátrica, enfocada en el diagnóstico, tipos clínicos y manejo farmacológico según guías MINSAL.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Bases neurobiológicas

- **Disfunción frontoestriatal:** reducción de actividad en corteza prefrontal dorsolateral, ganglios basales y cíngulo anterior.
- **Déficit en neurotransmisores dopamina y noradrenalina**, implicados en atención sostenida y control de impulsos.
- **Retraso madurativo cortical:** estudios de neuroimagen muestran que la maduración cortical es más lenta (2–3 años) en áreas frontales.

2.2. Factores genéticos y ambientales

- **Herencia:** componente genético fuerte (heredabilidad ~70–80%).
- **Factores de riesgo prenatal:** consumo de alcohol, tabaco o valproato durante embarazo, bajo peso al nacer, parto prematuro.
- **Factores psicosociales:** estrés familiar, disfunción parental, estilos de crianza inconsistente pueden agravar el cuadro pero no lo causan.

□ En suma, el TDAH es una **alteración neurobiológica del desarrollo del autocontrol y la atención**, con expresión conductual diversa según edad y contexto.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Presentación clínica según DSM-5

El DSM-5 define tres **subtipos clínicos** (actualmente llamados “presentaciones”):

Tipo	Características predominantes
Predominantemente inatento	Distracción, desorganización, olvidos, baja concentración.
Predominantemente hiperactivo-impulsivo	Inquietud motora, dificultad para esperar turnos, interrumpe, actúa sin pensar.
Combinado	Inatención + hiperactividad/impulsividad.

3.2. Criterios diagnósticos (DSM-5)

Se requieren **≥6 síntomas** (≥5 en mayores de 17 años) de **inatención** y/o **hiperactividad-impulsividad**, persistentes por **≥6 meses**, con inicio **antes de los 12 años**, presentes en **≥2 contextos** (escuela, hogar, social), y que causen deterioro funcional.

Síntomas de inatención

- No presta atención a detalles o comete errores por descuido.

- Tiene dificultad para mantener la atención.
- Parece no escuchar cuando se le habla directamente.
- No sigue instrucciones o no finaliza tareas.
- Dificultad para organizar actividades.
- Evita tareas que requieren esfuerzo mental sostenido.
- Pierde objetos con frecuencia.
- Se distrae fácilmente por estímulos externos.
- Olvida actividades diarias.

Síntomas de hiperactividad / impulsividad

- Mueve manos o pies constantemente, se levanta del asiento.
- Corre o trepa en situaciones inapropiadas.
- Dificultad para jugar tranquilamente.
- Habla en exceso.
- Responde antes de que terminen de preguntar.
- Dificultad para esperar su turno.
- Interrumpe o se entromete en conversaciones o juegos.

3.3. Evolución clínica por edad

Etapas	Manifestaciones predominantes
Preescolar (<6 años)	Inquietud motora, dificultad para permanecer sentado.

Escolar (6–12 años)	Bajo rendimiento académico, olvidos, conflictos con pares.
Adolescencia	Impulsividad, baja tolerancia a la frustración, conductas de riesgo.
Adultez	Desorganización, baja concentración, problemas laborales y de pareja.

3.4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Trastornos del aprendizaje	Dificultad específica (lectura, cálculo), sin hiperactividad.
Trastorno de ansiedad	Inquietud asociada a preocupación o miedo.
Depresión infantil	Inatención por anhedonia o fatiga.
Trastorno oposicionista desafiante (TOD)	Conducta desafiante intencionada, no por falta de control.
Trastorno del espectro autista (TEA)	Alteraciones sociales y comunicativas nucleares.
Privación sociocultural o negligencia	Inatención por estimulación inadecuada.

- ☐ La **persistencia transituacional** (en casa, escuela y otras áreas) es clave para diferenciar el TDAH de problemas conductuales aislados.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, basado en **entrevista estructurada** y **observación evolutiva**.

No existen exámenes de laboratorio o neuroimagen diagnósticos.

4.1. Evaluación en APS

- **Anamnesis completa:** antecedentes prenatales, desarrollo psicomotor, conducta escolar, ambiente familiar.
- **Entrevista a padres y profesores.**
- **Escalas estandarizadas:**
 - **Conners 3:** padres y profesores.
 - **SNAP-IV:** ampliamente utilizada en Chile.
 - **Vanderbilt:** para monitoreo de tratamiento.

□ El MINSAL recomienda evaluar con **escala SNAP-IV + entrevista familiar + informe escolar**, antes de derivar o medicar.

4.2. Evaluación complementaria

- **Audición y visión:** descartar déficit sensorial.
 - **Evaluación cognitiva (WISC o TONI):** si hay sospecha de bajo CI o aprendizaje.
 - **Descartar comorbilidades:** ansiedad, depresión, epilepsia, abuso de sustancias.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento debe ser **integral, multimodal y escalonado**, combinando **intervenciones psicosociales, educativas y farmacológicas**.

5.1. Intervenciones no farmacológicas

Primera línea en preescolares y complemento indispensable en escolares.

Intervención	Objetivo	Comentario
Psicoeducación familiar	Explicar la naturaleza neurobiológica del TDAH, reducir culpa y mejorar adherencia.	Fundamental.
Entrenamiento parental	Enseñar normas consistentes, refuerzo positivo, estructura y rutinas.	Alta eficacia.
Intervención escolar	Adaptaciones pedagógicas: instrucciones breves, refuerzos, asiento cercano al profesor.	Coordinación con PIE y MINEDUC.
Terapia cognitivo-conductual (TCC)	Entrenamiento en habilidades sociales y autorregulación.	Complementaria.
Apoyo psicopedagógico	Mejorar técnicas de estudio y organización.	Indicado en escolares.

□□ En Chile, el tratamiento conductual y educativo es parte del **Programa de Salud Integral de Niños y Adolescentes (MINSAL)**.

5.2. Tratamiento farmacológico

Indicado cuando:

- El TDAH genera **deterioro funcional significativo**,
- Han fracasado las medidas psicosociales, o
- Hay **riesgo de deserción escolar o problemas conductuales graves**.

a. Fármacos estimulantes

1. **Metilfenidato (de liberación inmediata o prolongada):**

- **Primera elección.**
- Mecanismo: inhibe recaptación de dopamina y noradrenalina.
- **Dosis inicial:** 0,3 mg/kg/día, ajustable hasta 1 mg/kg/día.
- **Duración:** 6–12 horas según formulación.
- **Efectos adversos:** insomnio, pérdida de apetito, irritabilidad, cefalea.
- **Contraindicaciones:** cardiopatía estructural, hipertensión grave, tics severos, glaucoma.

□ En Chile, el **MINSAL** entrega **metilfenidato de liberación prolongada** gratuitamente en el sistema público bajo diagnóstico confirmado.

b. Fármacos no estimulantes

1. **Atomoxetina:** inhibidor selectivo de recaptación de noradrenalina.
 - Útil en comorbilidad con ansiedad o tics.
 - Efectos secundarios: náuseas, somnolencia, hipotensión ortostática.
 2. **Guanfacina / clonidina:** agonistas alfa-2, menos usados, pero útiles en irritabilidad o trastornos del sueño.
 3. **Bupropión:** alternativa en adolescentes con depresión o abuso de sustancias.
-

5.3. Seguimiento y control

- Reevaluar cada 4–6 semanas al iniciar fármaco.
- Monitorear: apetito, peso, talla, presión arterial, frecuencia cardíaca.
- Control escolar trimestral para reportar evolución conductual y académica.
- Reevaluación integral anual (suspender medicación en vacaciones si está compensado).

□ El MINSAL recomienda mantener tratamiento farmacológico **por al menos 1 año** antes de considerar suspensión gradual.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Comorbilidades frecuentes

- Trastorno oposicionista desafiante (40–60%).
- Trastornos de ansiedad (30–40%).
- Depresión (20%).
- Trastornos del aprendizaje (20–30%).
- Trastornos del sueño.
- Consumo de sustancias en adolescencia (riesgo 3–5×).

6.2. Complicaciones no tratadas

- Bajo rendimiento académico.
- Fracaso escolar y deserción.
- Baja autoestima y problemas familiares.
- Conductas de riesgo (accidentes, sexualidad precoz, abuso de drogas).

6.3. Pronóstico

- En ~50% los síntomas persisten en la adultez (TDAH residual).
- Mejor pronóstico si:
 - Intervención temprana (<7 años).
 - Buen apoyo familiar y escolar.
 - Ausencia de comorbilidades graves.
 - Buena adherencia al tratamiento.

□ Con manejo integral, los niños pueden alcanzar desempeño escolar y social normales.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **diagnóstico es clínico** y requiere presencia en **≥2 contextos** (casa y escuela).
2. El **metilfenidato** es el fármaco de elección y su eficacia es la más demostrada.
3. El **TDAH no es causado por mala crianza**.
4. El **tratamiento conductual** es primera línea en menores de 6 años.
5. Siempre evaluar **comorbilidades** antes de iniciar medicación.
6. En adolescentes, controlar riesgo de **abuso de estimulantes**.
7. La **atomoxetina** es útil si hay ansiedad o contraindicación para estimulantes.
8. En Chile, el **tratamiento integral (psicosocial + farmacológico)** está cubierto por la red pública MINSAL.



Errores comunes

- Diagnosticar solo por informes escolares, sin evaluación familiar.
 - No verificar persistencia transituacional.
 - Indicar fármacos sin medidas psicoeducativas previas.
 - No controlar crecimiento ni presión arterial.
 - Suspender el tratamiento abruptamente.
 - Confundir TDAH con ansiedad o trastornos de conducta.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **TDAH** es un **trastorno neurobiológico del desarrollo** que afecta atención, control de impulsos y regulación motora.
2. El diagnóstico es **clínico**, basado en criterios DSM-5 y observación en **≥2 contextos**.
3. El **tratamiento es multimodal**, combinando **psicoeducación, intervención conductual y farmacoterapia**.
4. El **metilfenidato** es el fármaco de elección, seguro y eficaz, con seguimiento regular.
5. La **psicoeducación familiar y coordinación escolar** son esenciales para la adherencia y éxito terapéutico.
6. Las **comorbilidades** (ansiedad, oposición, aprendizaje) deben evaluarse y manejarse.
7. La intervención temprana mejora el **pronóstico académico, social y emocional**.